



# 拉沙热

2024年12月5日 | 阅读时间 9 分钟 (2325 字)

[English](#)

[العربية](#)

[Français](#)

[Русский](#)

[Español](#)

## 重要事实

- 拉沙热是一种由拉沙病毒引起的急性病毒性疾病。
- 已知拉沙热在贝宁、加纳、几内亚、利比里亚、马里、尼日利亚和塞拉利昂流行，但其他西非国家也可能存在拉沙热。
- 拉沙病毒主要通过接触被啮齿动物尿液或粪便污染的食物或家居用品传播给人类。
- 也可能发生人际间传播，特别是在缺乏适当感染预防控制措施的医疗卫生机构。
- 拉沙热的总病死率为1%，但观察到重症住院患者病死率为15%以上。
- 及早通过补液方式进行密集支持性护理和对症治疗可提高生存率。

## 概述

拉沙热是一种由拉沙病毒引起的急性病毒性疾病，1969年在尼日利亚首次发现。该病毒属于砂粒病毒科。

拉沙热是一种人畜共患病，人类会因接触受感染动物而被感染。拉沙病毒的动物宿主是乳鼠属啮齿动物，通常称为多乳鼠。感染拉沙病毒的乳鼠不会生病，但可以通过尿液和粪便排出病毒。

大约80%感染拉沙病毒的人没有症状或症状轻微。五分之一的感染会导致严重疾病，其中病毒会影响肝脏、脾脏和肾脏等多个器官。

由于临床过程非常多变，一直很难在受影响患者中发现该病。当社区证实出现拉沙热时，及早发现和迅速隔离和治疗患者，在医疗机构采取良好的感染预防控制措施，以及促进社区卫生和预防啮齿动物，可以防止疾病的进一步传播。

# 传播

人类感染拉沙病毒主要是通过接触被感染的乳鼠尿液或粪便污染的食物或家居用品，或直接通过接触感染的大鼠。

乳鼠在西非无处不在。它们可以生活在家中和周围，在储存食物的地方定居，并能够生活在田野或砍伐过的森林中。虽然乳鼠是主要宿主，但也从其他啮齿动物物种中分离出过拉沙病毒，表明它们可能也是感染源。

拉沙病毒也可能通过直接接触拉沙热感染者的血液、尿液、粪便或其他身体分泌物在人与人之间传播，但程度要小得多。人际间传播可能主要发生在卫生保健环境中，病毒也可能通过被污染的医疗设备传播，如重复使用的针头。

在缺乏适当感染预防和控制做法的情况下，卫生工作者在护理拉沙热患者时面临风险。

拉沙病毒可能在一些康复男性的精液中持续存在长达几个月。不过，迄今为止，还没有通过接触受感染精液传播的记录。

没有流行病学证据支持人与人之间会发生空气传播。

# 症状

拉沙热潜伏期为2至21天。

对于有症状患者而言，疾病的发作通常是渐进的，首先是发烧、全身无力、头痛和不适。几天后可能会出现喉咙痛、肌肉痛、胸痛、恶心、呕吐、腹泻、咳嗽和腹痛。随着病情的发展，严重者会出现面部肿胀、肺腔积液、口、鼻、阴道或胃肠道出血以及低血压。晚期可能出现休克、癫痫、震颤、丧失方向感和昏迷。在住院患者中，约15%死于拉沙热病。在致命病例中，死亡通常发生在症状出现后14天内。

怀孕期间感染拉沙热可导致孕产妇和胎儿死亡率上升，特别是在孕后期。在孕晚期，胎儿死亡率和孕产妇死亡率可分别超过80%和30%。

康复可能需要很长时间（康复期较长），有时会导致其他问题（后遗症）。急性期和康复后均可能突发听力损失，发生率有所不同，高达25%的康复患者报告发生突发性听力损失。据报告，大多数病例的听力损失是永久性的。其他后遗症包括神经系统体征、视力障碍、关节疼痛、短暂性脱发和心理障碍，报告的程度较低。因此，从拉沙热康复的患者应该针对可能经历的后遗症接受相关诊疗。

# 诊断

在临床上很难区分拉沙热与其他传染病，如疟疾、伤寒、志贺氏菌病、黄热病和其他病毒性出血热，特别是在病程早期。

可以采用以下诊断方法来证实症状是否由拉沙病毒感染所致：

- 逆转录聚合酶链反应检测
- 抗体捕获酶联免疫吸附试验
- 抗原检测试验
- 通过细胞培养进行病毒分离。

从患者身上采集的样本具有极高的生物危害风险；对未灭活样本的实验室检测应在最严格的生物封闭条件下进行。在国内和国际范围内运输时，所有未灭活生物标本均应使用三重包装。

## 治疗

通过液体管理和对症治疗及早进行密集支持性护理可提高生存率。

目前还没有抗病毒药物被批准用于拉沙热。抗病毒药物利巴韦林已被用于治疗拉沙热；然而，目前关于其对拉沙热患者的疗效以及最佳给药方案存在相当大的不确定性。只要有可能，应争取患者参加利巴韦林或其他研究治疗方法的随机临床试验，以评估临床结果和安全性。

其他候选治疗方案正处于开发和评估的不同阶段。

目前还没有获得许可的拉沙热疫苗，但正在开发几种潜在的候选疫苗。

## 预防与控制

### 减少啮齿动物向人类传播的风险

预防拉沙热依赖于限制与啮齿动物的接触。提倡良好的社区卫生，防止老鼠进入家居，并采取以下措施可能会有所帮助：

- 用防鼠容器储存粮食和食物
- 保持家居清洁，包括把垃圾弃置在远离家居的地方
- 安全地准备食物（例如彻底煮熟）。

由于乳鼠在流行地区非常丰富，因此不可能从环境中完全消除它们。

### 降低医疗机构中的传播风险

在卫生保健环境中，工作人员在照护患者时应采用标准的感染预防与控制措施，无论其推定诊断结果如何。这些措施包括注意基本的手卫生、呼吸卫生、使用个人防护装备以及安全注射操作。照护疑似或确诊拉沙热患者的卫生保健工作者应采取额外的感染控制措施，以防止接触患者的血液和体

液以及衣物和被褥等受到污染的表面或材料。实验室工作人员也面临风险。用于调查拉沙热感染的人类和动物样本应由经过培训的工作人员取样并在配有适当设备的实验室中在最严格生物封闭条件下处理。

## 及早识别疾病可以提高生存机会并限制传播风险

在拉沙热流行地区，特别是在流行季节，卫生工作者对出现提示症状的患者应高度怀疑拉沙热。家庭成员在照顾病人时应始终小心避免接触血液和体液。疑似或确诊拉沙热患者应转诊至指定的治疗中心接受早期护理。

## 从流行区返回的旅行者中的拉沙热

在极少数情况下，从流行地区返回的旅行者被确诊患拉沙热。虽然疟疾、伤寒和许多其他热带感染更为常见，但在诊断从西非返回的发热患者时应考虑拉沙热，特别是在他们在已知拉沙热流行区有过暴露的情况下。医护人员看到疑似拉沙热患者时，应立即联系当地和国家专家寻求建议，并安排实验室检测。

## 世卫组织的应对

世卫组织与拉沙热流行国和伙伴密切合作，通过支持监测活动、临床管理、实验室服务、感染预防和控制措施、后勤、培训和社区参与，支持防范和应对拉沙热。

产生进一步知识，包括诊断和治疗知识，以及各国和合作伙伴之间开展专业知识交流，对于促进拉沙热管理至关重要，特别是降低相关死亡率和限制医疗机构中的人际传播。